

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080923-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA

RECORRENTE: MARIA RITA ARAUJO SANTANA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MONITOR FREESTYLE® LIBRE E SENSOR DE FREESTYLE LIBRE®. EXISTÊNCIA DE INSUMOS E MEIOS DE CONTROLE DISPONÍVEIS NO ÂMBITO DO SUS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Intimem-se as partes e, preclusa a decisão, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5080923-16.2024.4.02.5101

510014809782 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080923-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA

RECORRENTE: MARIA RITA ARAUJO SANTANA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, interposta em face da decisão que negou a tutela provisória para fornecimento dos equipamentos Monitor FreeStyle® Libre e Sensor de FreeStyle Libre®, usado no monitoramento glicêmico em pacientes portadores de diabetes.

Segue a decisão recorrida:

Trata-se de ação movida por ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA, representado por MARIA RITA ARAUJO SANTANA, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, inclusive em sede de tutela de urgência, a condenação dos réus a lhe fornecerem Monitor FreeStyle® Libre e Sensor de FreeStyle Libre®.

Segundo o relatado na petição inicial, de acordo com laudo médico, emitido pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o autor, criança de 09 anos de idade, possui o diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID: E10), desde 2020, apresentando labilidade glicêmica e cetoacidose. Além disso, apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID: F84) e realiza o tratamento para sua condição utilizando fitas de medição capilares de glicemia. No entanto, devido ao Transtorno do Espectro Autista, apresenta dificuldade em identificar os quadros de hipoglicemia. Relata ainda que, além disso, costuma apresentar quadros de hipoglicemias, sem alarme, nos intervalos entre as medições capilares, conforme esclarece o formulário médico acostado aos autos.

Apresentado parecer técnico pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT-Jus no evento 31.

DECIDO.

O deferimento da tutela de urgência reclama o preenchimento das condições do art. 300, caput, do CPC, que impõe a presença, ao mesmo tempo, de probabilidade do direito alegado pela parte autora e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que o art. 4º da Lei nº 10.259/2021, que permite, ainda, a sua concessão de ofício pelo magistrado.

Ademais, deverá ser cumprido o pressuposto específico previsto no art. 300, §3º, do CPC, no sentido de que a tutela de urgência somente será deferida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, o laudo médico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (evento 1, ANEXO2, págs. 20) descreve o estado clínico da parte autora e traz a prescrição dos insumos

Encaminhados os autos ao Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT-Jus, foi elaborado Parecer Técnico contendo as seguintes informações:

Trata-se de Autor, 9 anos de idade, portador de **diabetes mellitus tipo 1**, com **cetoacidose**, apresentando labilidade glicêmica com hipoglicemias, além de transtorno do espectro autista (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 a 21), solicitando o fornecimento do insumo **monitor Freestyle® Libre e sensores** (Evento 1, INIC1, Página 9).

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do **Diabetes Mellito tipo 1**, do Ministério da Saúde, o diabetes mellito (DM) é uma doença endócrino-metabólica de etiologia heterogênea, que envolve fatores genéticos, biológicos e ambientais, caracterizada por hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina, que pode evoluir com complicações agudas (hipoglicemia, hiperglicemia, cetoacidose, retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana, doença arterial periférica e doença cerebrovascular). O tratamento do paciente com DM1 inclui cinco componentes principais: educação sobre diabetes, insulinoterapia, **automonitorização glicêmica**, orientação nutricional e prática monitorada de exercício físico¹.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o bom controle glicêmico é necessário que os pacientes realizem avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos. O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento e este pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela **monitorização contínua da glicose (MGC)**. Os resultados dos testes de glicemia devem ser revisados periodicamente com a equipe multidisciplinar e, os pacientes orientados sobre os objetivos do tratamento e as providências a serem tomadas quando os níveis de controle metabólico forem constantemente insatisfatórios. O monitoramento da Glicemia Capilar (GC) continua recomendado para a tomada de decisões no manejo de hiper ou hipoglicemia, mesmo em pacientes que utilizam monitoramento contínuo². →

Acrescenta-se que a Sociedade Brasileira de Diabetes solicitou a incorporação do Sistema flash de Monitorização da Glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) (que contempla o dispositivo pleiteado). A solicitação é subscrita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes (FENAD), ADJ Diabetes Brasil e Instituto Diabetes Brasil (IDB). No presente momento o pedido de incorporação se encontra em trâmite na CONITEC, em fase de análise, sem posicionamento sobre a incorporação³.

¹ BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellito Tipo 1. Brasília – DF, 2020. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_terapias_diabete_mellito.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

² Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Disponível em: <<https://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf>>. Acesso em: 25 set. 2024.

³ Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD. CONITEC – Chamada Pública nº 42/2024 – Freestyle Libre – Sistema flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2. Disponível em: <

Cabe ressaltar que o uso do SMCG não exclui a aferição da glicemia capilar (teste convencional e disponibilizado pelo SUS) em determinadas situações como: 1) durante períodos de rápida alteração nos níveis da glicose (a glicose do fluido intersticial pode não refletir com precisão o nível da glicose no sangue); 2) para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor; 3) quando os sintomas não corresponderem as leituras do SMCG^{4,5}.

Elucida-se que a monitorização da glicemia capilar necessita de uma pequena gota de sangue que habitualmente é adquirida na ponta do dedo, no entanto, existem sítios de coletas que configuram alternativas igualmente eficazes e menos dolorosas como: lóbulo de orelha, antebraço e panturrilha⁶.

Diante do exposto, informa-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** e sensores apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico do Autor, não são imprescindíveis. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Quanto à disponibilização de **FreeStyle Libre®** e sensores no âmbito do SUS, não estão padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

Considerando o exposto, informa-se que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está padronizado pelo SUS para distribuição gratuita aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes – **HIPERDIA**.

Para o acesso ao glicosímetro ofertado pelo SUS, sugere-se que a representante do Autor compareça a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Destaca-se que o aparelho **FreeStyle Libre®** possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)⁷.

É o Parecer

À 33ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.


FLÁVIO AFONSO BADARÓ
Assessor-chefe
CRF-RJ 10.277
ID. 436.475-02

VIRGINIA GOMES DA SILVA
Enfermeira
COREN/RJ 321.417
ID. 4.455.176-2

O NAT-Jus afirma que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está coberto pelo SUS para o quadro clínico da autora e que o equipamento glicosímetro capilar e os insumos tiras reagentes e lancetas estão padronizados para distribuição gratuita, no âmbito do SUS, objetivando o controle glicêmico dos pacientes dependentes de insulina.

Afirma, também, que para o acesso ao glicosímetro ofertado pelo SUS, sugere-se que a representante do autor compareça à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Após a análise dos autos e feitas essas premissas, verifico que não estão presentes todos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, pois não é possível concluir acerca da imprescindibilidade do tratamento, mormente porque não foi demonstrado o esgotamento ou a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS.

*Isso posto, **INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**, sem prejuízo de superveniente reexame da questão por ocasião da prolação da sentença ou no caso de alteração do quadro fático-jurídico exposto na peça inaugural.*

Intimada, a União não apresentou contrarrazões.

VOTO

A pretensão não se funda em urgência ou evidência, diante do parecer do NAT juntado nos autos principais, do qual se transcreve os seguintes excertos:

*Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o bom controle glicêmico é necessário que os pacientes realizem avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos. **O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento e este pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) ou pela monitorização contínua da glicose (MGC). Os resultados dos testes de glicemia devem ser revisados periodicamente com a equipe***

multidisciplinar e, os pacientes orientados sobre os objetivos do tratamento e as providências a serem tomadas quando os níveis de controle metabólico forem constantemente insatisfatórios. O monitoramento da Glicemia Capilar (GC) continua recomendado para a tomada de decisões no manejo de hiper ou hipoglicemia, mesmo em pacientes que utilizam monitoramento contínuo².

(...)

Diante do exposto, informa-se que o aparelho FreeStyle Libre® e sensores apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico do Autor, não são imprescindíveis. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Quanto à disponibilização de FreeStyle Libre® e sensores no âmbito do SUS, não estão padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

Considerando o exposto, informa-se que o teste de referência preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) está padronizado pelo SUS para distribuição gratuita aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes - HIPERDIA.

Para o acesso ao glicosímetro ofertado pelo SUS, sugere-se que a representante do Autor compareça a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

(grifo nosso)

Por existir meios de medição dos índices glicêmicos com insumos disponibilizados pelo SUS, o tratamento não seria prejudicado sem o insumo pretendido. Portanto, não há urgência nem evidência na pretensão.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Intimem-se as partes e, preclusa a decisão, arquivem-se.